

ZASADY ŚWIADCZENIA POMOCY WOLONTARIUSZA FUNDACJI „OSTATNIA WARTA”

§ 1

Granice kompetencji (Brak działań medycznych). Pod żadnym pozorem nie wykonuj medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych (podawanie leków, obsługa kroplówek, iniekcje, skomplikowane czynności pielęgnacyjne). Fundacja „Ostatnia Warta” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieuprawnionych działań medycznych. Pamiętaj jednak: obywatelska pierwsza pomoc (w tym RKO – uciskanie klatki piersiowej) NIE jest czynnością medyczną. Jej podjęcie lub celowe zaniechanie jest uzależnione wyłącznie od statusu podopiecznego (patrz § 6).

§ 2

Bezwzględna dyskrekcja To, co dzieje się w sali chorego, zostaje w sali chorego. Masz absolutny zakaz robienia zdjęć podopiecznym bez wyraźnej zgody Fundacji oraz opowiadania o szczegółach ich stanu zdrowia osobom postronnym.

§ 3

Bezinteresowność Pomoc jest w 100% darmowa. Obowiązuje kategoriyczny zakaz przyjmowania od podopiecznych i ich rodzin pieniędzy, drogich prezentów oraz darowizn. Ewentualne darowizny należy przekierować na oficjalne konto bankowe Fundacji.

§ 4

Prawo do słabości i dbanie o siebie Nie jesteś ze stali. Praca z umierającymi jest trudna. Masz pełne prawo powiedzieć: „Dzisiaj nie dam rady pójść na dyżur” lub „Ta historia mnie przerasta, potrzebuję przerwy”. Zgłaszaj to koordynatorowi – zapewnimy Ci rozmowę odbarczającą lub dłuższą pauzę w dyżurach. Twoje zdrowie psychiczne jest dla nas priorytetem.

§ 5

Nie obiecuj tego, czego nie możesz spełnić Nie mów pacjentowi „Wszystko będzie dobrze”, kiedy wiesz, że nie będzie. Nie obiecuj, że przyjdiesz jutro, jeśli wiesz, że możesz nie dać rady. W opiece paliatywnej najbardziej liczy się szczerłość, spokój i cicha obecność,

§ 6

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych (Nagłe pogorszenie zdrowia lub zgon) Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa karnego (w szczególności prawnokarnego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy – art. 162 k.k.) oraz różnic między ratowniczą pierwszą pomocą a zastrzeżonymi dla lekarzy medycznymi czynnościami ratunkowymi, Fundacja różnicuje schemat Twojego działania. Twój plan reakcji zależy od miejsca, w którym pełnisz dyżur, oraz medycznego statusu Podopiecznego. Wolontariusz przed rozpoczęciem jakiegokolwiek dyżuru musi dowiedzieć się od Koordynatora, czy podopieczny znajduje się w fazie terminalnej (objęty opieką hospicjum).

1. W placówkach medycznych całodobowych (Szpital, Hospicjum Stacjonarne, ZOL): W tych wyspecjalizowanych placówkach za bezpieczeństwo odpowiada personel

medyczny. Twoim jedynym zadaniem jako wolontariusza asystującego jest natychmiastowe zaalarmowanie i wezwanie do sali pielęgniarstwa lub lekarza dyżurnego. Nie podejmuj samodzielnie żadnych działań. Dopiero po ich interwencji powiadamasz koordynatorów Fundacji o incydencie.

2. W środowisku domowym podopiecznego – KLUCZOWY PODZIAŁ NA STATUS PACJENTA:

A. Podopieczni NIETERMINALNI (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami wspierane w funkcjonowaniu, bez orzeczonej opieki hospicyjnej/paliatywnej):

Jeśli stan zdrowia podopiecznego, u którego lekarz nie zdiagnozował stanu terminalnego, drastycznie się pogarsza, traci on przytomność lub przestaje oddychać:

- Zaalarmuj domowników, wzywając pomocy na głos.
- Jeśli pełnisz dyżur sam, **natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.**
- **Bezwzględny Obowiązek Pierwszej Pomocy:** W oczekiwaniu na zespół pogotowia masz prawny obowiązek (art. 162 k.k.) udzielić pierwszej pomocy. Jeśli podopieczny nie oddycha, musisz natychmiast rozpocząć uciskanie klatki piersiowej (RKO). **Pamiętaj: pierwsza pomoc to obowiązek, a NIE zakazana w Fundacji „czynność medyczna”.** Słuchaj wytycznych dyspozytora 112.

B. Podopieczni TERMINALNI / PALIATYWNII (opieka hospicjum domowego): W przypadku chorych, u których medycyna ostatecznie wyczerpała możliwości leczenia, nadchodząca śmierć jest naturalnym etapem zamykającym trajektorię życia. Podejmowanie fizycznej reanimacji wobec osoby spokojnie umierającej przedłuża jej agonię i traktowane jest jako **potępiana terapia uporczywa.**

- **Zasada „Nie ingeruj”:** Jeśli pacjent paliatywny odchodzi w trakcie Twojego dyżuru, zachowaj powagę i spokój. Masz pełne prawo moralne i prawne nie podejmować żadnych inwazyjnych działań reanimacyjnych (RKO) – prawo nie uznaje tego za przestępstwo.
- Powiadom obecną w domu rodzinę. Jeśli pełnisz dyżur sam, odnotuj godzinę ustania oddechu. Skontaktuj się ze wskazanym lekarzem/pięgniarką hospicjum domowego (lub z rodziną).
- W przypadku przewidywanego zgonu paliatywnego w domu, nie dzwoń rutynowo na 112. Bezwzględnie nie zmieniaj fizycznego ułożenia ciała po jego zwińczeniu do czasu przyjazdu lekarza.

3. Obowiązek Powiadomienia Władz Fundacji: Niezależnie od charakteru zaistniałej sytuacji, w momencie, gdy sytuacja na miejscu zostanie przejęta przez służby lub bliskich, niezwłocznie zadzwoń do Zarządu – Przemka lub Moniki. Musimy wiedzieć o tym zdarzeniu tak szybko, jak to możliwe, aby udzielić Ci natychmiastowego wsparcia psychologicznego i odciążyć Cię z dalszych obowiązków na ten a być może najbliższe dni.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się, zrozumienie i przyjęcie do stosowania wyżej opisanych zasad świadczenia pomocy.

.....
Data, miejsce i podpis Wolontariusza